

Концептуальный взгляд на оптимизацию дифференциальной диагностики карциномы и опухолеподобных патологий поджелудочной железы

Бердаuletов С.Б., Аязбаев Ш.У.
Мангистауская областная больница. Актау

Актуальность

Дифференциальная диагностика опухоли и опухолеподобных патологий поджелудочной железы (ПЖ), особенно протокового рака или аденокарциномы головки ПЖ и псевдотуморозного панкреатита является актуальной. В клинической практике встречаются случаи длительного наблюдения больных без специального лечения у онкологов с диагнозом рак ПЖ с последующим снятием их с диспансерного учета и наоборот. С указанным негативным явлением связаны психологическая нагрузка больных и их близких, потеря работы, установление инвалидности и т.д. Дифференциальная диагностика опухоли и опухолеподобной патологии ПЖ нередко становится непреодолимой дилеммой. Известны единичные случаи установления наличия рака ПЖ во время хирургической операции и опровержения указанного диагноза через несколько месяцев.

Цель исследования

Определение диагностических возможностей магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии (КТ) при опухолях ПЖ.

Материалы и методы

В 2010 году в Мангистауской областной больнице начали выполнять перфузионную КТ поджелудочной железы с целью дифференциальной диагностики рака ПЖ и псевдотуморозного панкреатита и вскоре столкнулись со следующими трудностями. Имевшийся двухсрезовый компьютерный томограф не позволял выполнить КТ-перфузии по следующей методике: получение 1 изображения в секунду после болюса 40-50 мл контраста при длительности сканирования 45 сек и в связи с этим оказался невозможной определение средней времени транзита, объема кровотока и панкреатического кровотока. Стандартная платформа PC Advantage 4,0 не имела программу (протокол) перфузии

Обсуждаются подходы к дифференциальной диагностике опухолевых заболеваний поджелудочной железы с использованием перфузионной компьютерной томографии.

This paper is discussed approaches to differential diagnostics of tumoral diseases of a pancreas with using of perfusion computer tomography.

для ПЖ.

Результаты и обсуждение

Основным методом диагностики патологии ПЖ является КТ. Нативная КТ информативна не только в 64%. По данным Г.Г.Кармазановского и соавторов в диагностике опухолей ПЖ приоритетна КТ с болюсным контрастным усилением. Во многих клиниках с этой целью используют динамическую болюсную КТ, в частности, КТ по Станфордскому протоколу, предусматривающей получение изображений поздней артериальной и портоинозной фаз (40 сек, 80 сек). По данным ряда авторов, КТ в артериопаренхиматозную и портальную фазу не информативны только в 6% и 9% соответственно.

В мировой литературе пока крайне ограничено число сообщений о диагностической ценности КТ-перфузии поджелудочной железы (рСТ). рСТ- кратковременный болюс контрастного вещества, во время прохождения которого получают повторяющиеся через одинаковый промежуток времени один или несколько срезов.

В настоящее время используются многосрезовые КТ и программные пакеты с Perfusion. На подобных КТ-системах можно выполнить перфузионную КТ и установить диагностическую ценность перфузионных характеристик различных истинных опухолей и опухолеподобных патологий поджелудочной железы.